¿Cómo financiar la salud universal?

Espacio fiscal, aseguramiento y una agenda regional

Héctor Juan Villarreal Páez

ITED · Escuela de Gobierno y Transformación Pública · Tecnológico de Monterrey
Comunidad Latinoamericana del Conocimiento sobre Financiamiento de la Salud

Foro *Los retos del espacio fiscal en México* · Sesión 2
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026

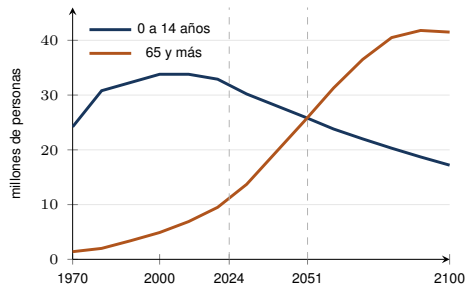
Gasto en salud

- En la sesión anterior se habló del panorama general del espacio fiscal. Yo me voy a concentrar en el **gasto en salud**.
- Para financiar la salud universal hay que contestar tres preguntas: quién paga, cuánto y por cuánto tiempo.
- La tercera es la que menos se discute, y de ella depende que una reforma dure.

Voy a tocar cuatro temas: lo que ya definió la demografía, lo que queda en el presupuesto, nuestra propuesta y lo que queremos investigar con otros países de la región.

México: menores de 15 y mayores de 65

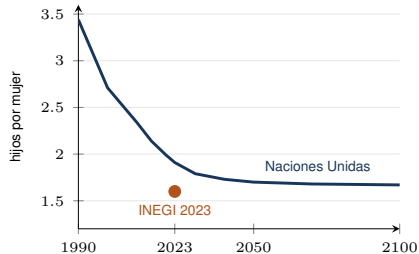
- La población de 65 años y más pasará de **10.8 millones** en 2024 a **25.3 millones** en 2050.
- Alrededor de **2051** habrá más personas de 65 y más que menores de 15 años.
- Las personas de 80 y más se triplican: de **2.1** a **6.5 millones**. Es el grupo que más gasta en salud y en cuidados.



Naciones Unidas, DESA, *World Population Prospects 2024*, variante media. Cálculos propios.

¿Y si Naciones Unidas se queda corta?

- Para 2023, Naciones Unidas estima **1.91** hijos por mujer en México, y supone que en ningún año del siglo baja de **1.66**.
- El INEGI midió **1.6** en 2023, y **1.44** en zonas urbanas.
- Fernández-Villaverde ha mostrado que las proyecciones oficiales tienden a sobreestimar la fecundidad.



Si tiene razón, el envejecimiento llega antes. Aquí usamos las cifras de Naciones Unidas, que son las más favorables.

ONU, WPP 2024; INEGI, ENADID 2023; Fernández-Villaverde (2023). Detalle de fuentes al final.

También cambia la forma en que nos enfermamos

- Las enfermedades no transmisibles ya explican **60.1 %** de los años de vida perdidos por muerte prematura o discapacidad.
- Diabetes, hipertensión, cáncer: son padecimientos crónicos que se atienden durante años.
- El IMSS calcula que su prima de equilibrio para atención médica tendría que subir **34 %** para cubrir sus gastos.

Esta presión va a crecer con o sin reforma. Viene de la demografía y del perfil epidemiológico del país.

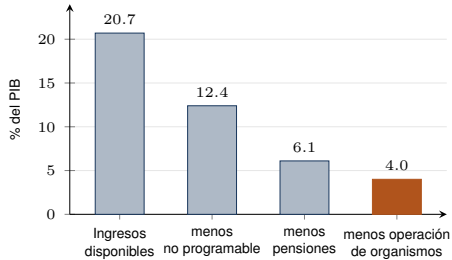
CIEP (2026), *Implicaciones del Paquete Económico 2027*, con base en IHME, OMS e IMSS.

Esto ya no depende de nosotros.

Lo que sigue, sí.

¿Cuánto queda para decidir?

- Los ingresos disponibles son **20.7 %** del PIB. Dejamos fuera el petróleo: lo que entra por el Fondo Mexicano del Petróleo sale como apoyo a Pemex.
- Les restamos lo que no se decide año con año: gasto no programable, pensiones y la operación propia de IMSS, ISSSTE y CFE.
- Queda **4.0 %** del PIB, más deuda, para salud, educación, infraestructura, seguridad, cuidados y todo lo demás.



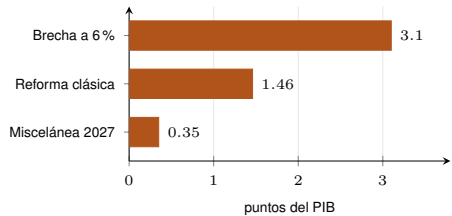
Restas: no programable 8.3 (costo financiero 3.8, participaciones 4.2, Adefas 0.3); pensiones 6.3; operación propia 2.1.

Son sólo sumas y restas, sin supuestos de comportamiento. Y 4.0 % es el máximo.

Villarreal, *Contabilidad de la Muerte*, actualización 2026, con SHCP, Informe enero–julio 2026.

La brecha en salud

- En 2027 el gasto público en salud sería **2.9 %** del PIB. Para llegar al 6 % que recomienda la OPS faltan **3.1** puntos.
- Una reforma fiscal clásica completa (IVA, ISR y gastos fiscales) daría alrededor de **1.5** puntos.
- La Miscelánea 2027 aporta entre **0.34** y **0.36** puntos.



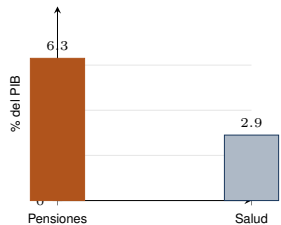
Una reforma fiscal ambiciosa, por sí sola, no alcanza para financiar la salud universal.

CIEP (2026); OPS (2014); estimación propia del paquete de reforma clásica. Detalle de fuentes al final.

Las pensiones le quitan espacio a la salud

- El PPEF 2027 asigna **6.3 %** del PIB a pensiones y **2.9 %** a salud: más de dos pesos a pensiones por cada peso a salud.
- Las pensiones contributivas crecen **4.7 %** real, sobre todo por IMSS e ISSSTE. Es gasto comprometido desde hace años.
- Si no aumentan los ingresos, cada punto adicional en pensiones es un punto menos para salud.

Por eso la reforma de pensiones y el financiamiento de la salud hay que verlos juntos.



CIEP (2026), *Implicaciones del Paquete Económico 2027*, caps. 5 y 10.

¿Financiar todo con impuestos generales?

- Un sistema financiado sólo con impuestos generales requiere una recaudación alta y estable.
- México recauda alrededor de **18 %** del PIB, cerca de la mitad de lo que tenían los países que lograron cobertura universal por esa vía.
- Además, cada peso adicional que se recaude compite con las pensiones y con el costo de la deuda.

Con la recaudación actual, una salud universal financiada sólo con impuestos no es viable.

La pregunta es cómo ampliar el aseguramiento, no cómo sustituirlo.

Salud en el presupuesto 2027

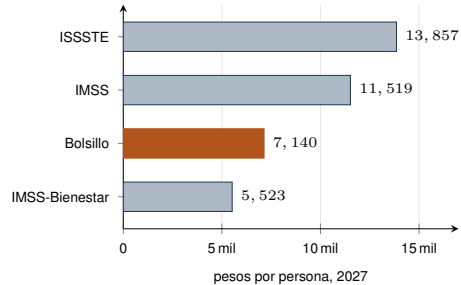
- El gasto en salud aumenta **10.6 %** real y llega a **1.14 billones** de pesos. Si se descuenta la inflación de los servicios médicos, el aumento es de **8.6 %**.
- El **75.6 %** del aumento se va a población con seguridad social: IMSS crece **11.6 %**, ISSSTE **18.8 %** e IMSS-Bienestar **9.0 %**.
- De ese total, **760 mil millones** (**67 %**) son para la población con seguridad social y **376 mil millones** (**33 %**) para el resto. Para el resto, el aumento es de **7.6 %** real.

El aumento recupera parte de los recortes recientes, pero la estructura sigue igual.

CIEP (2026), *Implicaciones del Paquete Económico 2027*, cap. 5, con base en SHCP.

Dos sistemas y el gasto de bolsillo

- El gasto público por derechohabiente del IMSS es **2.1** veces el de una persona atendida por IMSS-Bienestar.
- El gasto de bolsillo por persona es **29.3 %** mayor que el gasto público por persona en IMSS-Bienestar.
- Los hogares del primer decil gastan en salud **3.9 %** de su ingreso; los del décimo, **2.1 %**.



Bolsillo: 2024, a precios de 2027.

CIEP (2026), cap. 5, con base en SHCP e INEGI (ENIGH 2024).

El dilema Gruber

- En un sistema mixto es muy difícil dar el mismo servicio de salud cuando unos contribuyen y otros no.
- Si el servicio es igual para todos, ¿para qué cotizar? Si es distinto, terminamos con dos sistemas.
- Un sistema de salud tiene que lograr dos cosas: que nadie se **empobrezca** por enfermarse, y que **convenga** estar en el sistema contributivo.

En México, como en el resto de la región, se ha avanzado en una o en otra, pero rara vez en las dos al mismo tiempo.

El planteamiento es de Jonathan Gruber (MIT).

El costo de formalizarse

- Al formalizarse, un trabajador empieza a pagar cuotas e impuestos y, en algunos casos, deja de recibir apoyos.
- El Banco Mundial encuentra que, en América Latina, la mayor parte de ese costo corresponde a las **contribuciones de seguridad social**.
- Quién paga realmente las cuotas, el trabajador o la empresa, depende de cómo se ajustan salarios y empleo. Para México no lo tenemos bien medido.
- Lo que sí sabemos es que no todas las cuotas pesan igual: la **cuota fija** pesa proporcionalmente mucho más en los salarios bajos.

Si el trabajador no valora lo que recibe a cambio, la cuota se percibe como un impuesto más. El diseño puede cambiar eso.

Fietz et al. (2025), *(In)Formalizing Jobs in LAC*, Banco Mundial. Detalle de fuentes al final.

Bismarck, Beveridge y nuestra propuesta

Decisión	Bismarck	Beveridge	Nuestra propuesta
¿Con qué se financia?	Cuotas obrero-patronales	Impuestos generales	Se mantienen las cuotas obrero-patronales; quien no cotiza paga una prima según su ingreso; el gobierno completa
¿La prima es de cada persona?	Sí	No	Sí
¿Quién la paga?	Trabajador y patrón (en México, también el gobierno)	El gobierno	Asalariados, igual que hoy. Los demás, según su ingreso; el gobierno paga la prima completa sólo a los más pobres
¿El derecho depende del pago?	Sí	No, basta con residir	Sí, y todos tienen su prima cubierta

Nuestra propuesta combina de otra manera las mismas cuatro decisiones.

Cómo funcionaría

- Quien tiene empleo formal sigue pagando sus **cuotas obrero-patronales**, como hoy. Lo que cambia es que debe ver con claridad qué paga y qué recibe.
- Quien no cotiza se inscribe en los seguros médicos del IMSS y paga una **prima según su ingreso**. El gobierno completa la diferencia.
- Sólo a la población más pobre el gobierno le paga la prima completa, como un impuesto negativo. Si la pagara para todos, se perdería el incentivo a cotizar.

Todos dentro del mismo sistema de aseguramiento, sin esquemas paralelos.

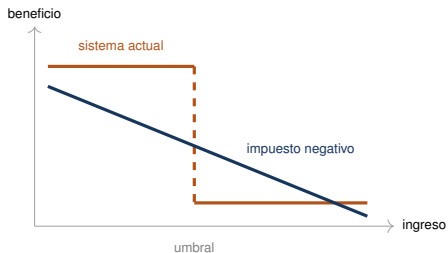
El IMSS como sistema nacional de seguros de salud

- Partimos de lo que existe. El IMSS tiene los hospitales, el personal, buena parte de la formación de especialistas y el registro de derechohabientes. Para la población sin seguridad social, en cambio, el modelo cambió tres veces entre **2019** y **2023**.
- Que el IMSS agrupe los servicios de salud ligados al empleo formal: ISSSTE, Pemex e incluso fuerzas armadas.
- Que se dedique sólo a salud. Pensiones y cuidados, en otras instancias.
- Que pueda funcionar como caja de compensación y contratar servicios privados con recursos públicos.

Diario Oficial de la Federación, 29-XI-2019, 31-VIII-2022 y 29-V-2023; Villarreal (2024). Detalle de fuentes al final.

Consolidar transferencias

- Los programas con límites de ingreso generan un escalón: quien rebasa el límite pierde el apoyo completo.
- Con un **impuesto negativo sobre la renta**, el apoyo baja poco a poco conforme aumenta el ingreso, y formalizarse siempre conviene.
- Esto requiere medir bien los ingresos. La factura electrónica, los pagos digitales y el RFC como padrón único lo hacen posible.

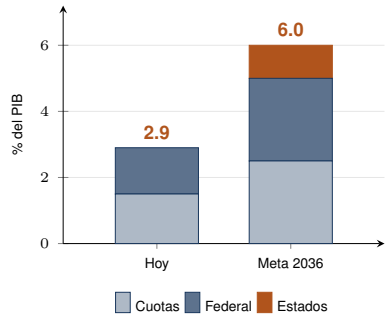


Esquema conceptual, sin escala.

¿De dónde saldría el 6 % del PIB?

- **Cuotas de salud:** de **1.5 %** a **2.5 %** del PIB, con el crecimiento de la masa salarial y la formalización.
- **Gobierno federal**, sin contar cuotas: de **1.4 %** a **2.5 %**, sumando **0.1** puntos cada año. La fuente serían los gastos fiscales.
- **Estados y Ciudad de México: 1 %** del PIB, con participaciones e ingresos propios, sobre todo predial.

Nada de esto funciona si no se contiene el gasto en pensiones.



Hoy: aportación estatal propia no desglosada.

Villarreal (2024), "¿Se puede reformar la seguridad social? Parte II", *Arena Pública*.

Financiamiento privado

- Con una meta de **8 %** del PIB en salud hacia 2036, **6** puntos serían públicos y **2** privados: alrededor de **25 %** del total, contra la mitad o más de hoy.
- Lo importante es que el gasto privado sea prepago, y no gasto de bolsillo por urgencias.
- Dos frentes: regular los consultorios adjuntos a farmacias y conectarlos con el resto del sistema; y desarrollar seguros médicos privados de bajo costo, con estímulos fiscales o descuentos en la prima del IMSS.
- Una pregunta abierta: seguros de largo plazo que se paguen durante la vida laboral y cubran en la vejez.

Villarreal (2024), "¿Se puede reformar la seguridad social? Parte II", *Arena Pública*.

Dos preguntas para cualquier propuesta

1. ¿Se puede pagar durante toda la transición demográfica sin que la deuda se vuelva insostenible?
2. ¿Fortalece o debilita el incentivo a cotizar?

Si una propuesta falla en alguna de las dos, tiene un problema de fondo. Esto aplica a lo que propongo y a cualquier alternativa. Para contestar la primera hay que hacer la cuenta completa: salud, pensiones y reforma fiscal juntas.

La Comunidad

- En la región se ha discutido mucho cómo ampliar la **cobertura** en salud, y mucho menos cómo **pagarla** en los próximos veinte o treinta años. De ahí surge la Comunidad.
- La fundan tres instituciones:
  - Tecnológico de Monterrey — coordinación, Héctor Villarreal
  - Universidad de los Andes, Colombia — Ramiro Guerrero
  - Pontificia Universidad Católica de Chile — Pablo Celhay
- Es un proyecto de al menos cinco años. Ya hay tres trabajos en curso, uno en cada institución, que se complementan entre sí.

Preguntas abiertas

1. ¿Qué parte del gasto de bolsillo podría convertirse en prepago?
2. ¿Con qué reglas el financiamiento privado complementa al público en lugar de debilitarlo?
3. ¿La detección temprana ahorra recursos, o sólo adelanta y alarga el gasto?
4. ¿Cuánto espacio dejan las pensiones para la salud en los próximos veinte años?

Estamos armando un **mapa de investigadores** en la región y buscamos datos que permitan comparar países. La primera reunión de trabajo será en **San José, Costa Rica, del 5 al 7 de octubre**.

¿Podemos diseñar un sistema de salud que la gente valore lo suficiente para querer participar, y que el país pueda pagar durante su transición demográfica?

Héctor Juan Villarreal Páez · hjvp@itesm.mx
Escuela de Gobierno y Transformación Pública · Tecnológico de Monterrey

Fuentes (1/2)

Demografía. Naciones Unidas, DESA, División de Población, *World Population Prospects 2024*, variante media, México; grupos de edad agregados a partir del archivo oficial por grupos quinquenales (cálculos propios). La revisión 2026 fue pospuesta a 2027. INEGI, *Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023*. INEGI, *Estadística de Nacimientos Registrados 2024*. Fernández-Villaverde, J. (2023), *The Demographic Future of Humanity: Facts and Consequences*.

Presupuesto 2027, salud y pensiones. CIEP (2026), *Implicaciones del Paquete Económico 2027*, 11 de septiembre de 2026: gasto en salud, gasto per cápita por subsistema, gasto de bolsillo, inflación de salud, carga de enfermedad (IHME, 2021; OMS, 2024), prima de equilibrio del IMSS (IMSS, 2024), pensiones, Miscelánea e ingresos petroleros. Meta de 6 % del PIB: OPS (2014), *Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud*.

Espacio disponible. Villarreal, *Contabilidad de la Muerte*, actualización con el Informe de Finanzas Públicas enero–julio 2026 (SHCP). PIB nominal de 36,500 mmdp, menor al de Pre-Criterios 2027; el supuesto favorece a la cuenta oficial. CIEP (2026) estima un espacio fiscal de 1.6 % del PIB con una definición distinta.

Fuentes (2/2)

Reforma fiscal clásica. Estimación propia del rendimiento de un paquete de reforma clásica (IVA, ISR y gastos fiscales), alrededor de 1.5 puntos del PIB.

Trampa de la formalización. Fietz, Joubert, Ñopo, Ocampo, Packard, Posadas y Rodriguez Chamussy (2025), *(In)Formalizing Jobs in Latin America and the Caribbean: Taxes, Benefits, and Labor Market Incentives*, Banco Mundial, cap. 5.

Modelo de aseguramiento y metas de financiamiento. Villarreal, H. (2024), "¿Se puede reformar la seguridad social? Parte II", *Arena Pública*, 10 de septiembre de 2024. Dilema de Gruber: Jonathan Gruber (MIT).

Arquitectura institucional. Diario Oficial de la Federación: 29-XI-2019 (Insabi), 31-VIII-2022 (IMSS-Bienestar), 29-V-2023 (reforma a la Ley General de Salud).

Comunidad. Documento de presentación de la iniciativa; reunión de trabajo en San José, Costa Rica, 5–7 de octubre de 2026.